جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : نجلاء عبدالعظيم محمد محمود
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** الساحل **العنوان :** الترعه البولاقيه
رقم البطاقة : 28509300112108 **رقم التليفون :** 01029277006 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 30-09-1985 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: نجلاء عبدالعظيم محمد محمود
National ID: 28509300112108



تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]
National ID – Front & Back

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



نجلاء
عبدالعظيم محمد محمود
١٩ ش مرزوق-ش الترعة البولاقية
الساحل - القاهره

١٩٨٥/٠٩

٢٨٥٠٩٣٠٠١١٢١٠٨

LI5533139

٠١٠٢٩٢٧٧٠٦

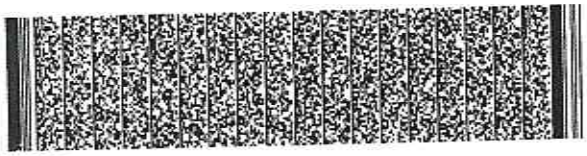
٠١٠٥٠٢٦٢٩٠

على كم ١٤/٩/٢٠٢٦

٢٨٥٠٩٣٠٠١١٢١٠٨ ٢٠٢٥/٠٨
بدون عمل



انثى مسلمة متزوجة
احمد فاروق محمد سليم
١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٨/٢٣



[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]
Mammogram

اسم المريض بالإنجليزية: Naglaa Abd Alazim Mohamed	كود المريض: 99258
تاريخ التقرير: 2026/09/13 11:31:08 AM	السن: ٤٠ سنة, ١١ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 40 years old female patient with right breast lump 4 months ago.

Detailed Findings

Right breast:

- Heterogeneously dense (ACR density C).
- The right breast shows locally advanced pathological process inform of middle/posterior 1/3 UOQ and upper central multiple interconnecting ill-defined spiculated dense mass lesions with overlying regional clustered suspicious microcalcifications and thickened skin measuring about 12.5 mm.
- **Ultrasound** revealed locally advanced pathological process inform of three large ill-defined hypoechoic mass lesions seen retroareolar and 9-11 O'clock measuring collectively about 15 x 12.5 cm at its maximum diameters. Associated diffuse echogenic fat lobules with overlying skin thickening.
- Multiple enlarged axillary lymph nodes at level I, II & III with effaced hila, largest one measures about 20 x 12 mm at level I.

Left breast:

- Heterogeneously dense (ACR density C).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated prominent glandular elements of the breast tissue with mottled appearance.
- Well circumscribed hypoechoic mass lesion showing angulated margins seen at 1 O'clock measuring about 15 x8 mm
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Right breast (BIRADS 5): Right locally advanced pathological process with malignant mass lesions with ipsilateral pathological axillary lymph nodes as described. For tru cut biopsy and CESM is recommended.**
- **Left breast (BIRADS 3): Left UOQ probably benign lesion as described likely fibroadenoma.**

Much obliged,
Dr. Rania Mostafa
Dr. Hedaya Nour, MD

[[DOCTYPE:MDT_FORM]]
MDT Form

جوستاف روسي انترناشونال مصر

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

الست المصرية هي صحة مصر

MDT FORM 14 / 10 / 2026 G

Name	خلاء العلم	MRN	14712
		ID	
Age	٤٥	Phone	
Menopausal status	Pre	Marital status	Married
NRS SCORE		Family history	-ve
BMI		REASON OF MDT	New
CO morbidity	NAD		

Clinical Data

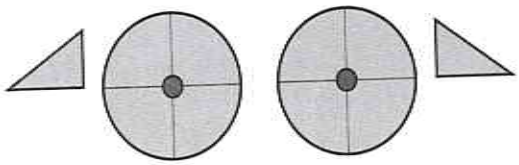
BX: Rt + IDC3

ER:	PR:	HER 2:	Ki67:
61%	41%	3+	50%

Sonomammography: Rt Locally advanced breast ca

Mets Workup: NCRC

R L



T N M

Recommendations: Rt CESM

MDT OUTCOME & PLAN

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]
Pathology Report

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL
Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي الترناشونال – مصر معمل الباثولوجي
جوستاف روسي

Patient Name	نجلاء عبدالعظيم محمد محمود	**Case No.**	**385518**
Sex/Age	**Female 40 Y**	**Patient No.**	**29016**
Registered Date	**19/9/2026 09:15:51 AM**	**Referred By Dr.**	**Out Patient**
Validation Date	**29/9/2026 11:46:23 AM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**07/10/2026 10:35:27 AM**	**Pathology No.**	**2973/26**

Pathology Report

Clinical Data: Right breast mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 16/09/2026, at 1:40 pm. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:
-Fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.2 cm & 1.2 cm long, totally submitted.

Technique:
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:
-Histologic type: Invasive duct carcinoma.
- Histologic grade: 3 (differentiation 3, pleomorphism 3, mitosis 2).
- DCIS: Present, moderate grade, solid with comedo necrosis.
- Microcalcification: Absent.
- Angioinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.
- Tumor infiltrating lymphocytes (TILs): Moderate.
- Additional pathological findings: Positive necrosis.

Results:
* IPT (All controls showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Moderate nuclear reaction in 1% of tumor cells (score 4/8).
- Her2: Strong complete membrane reaction in more than 10% of the tumor cells (score 3+).
- Ki67%: 50%.

Conclusion:
Right breast mass, Tru-cut biopsy:
-Invasive duct carcinoma, Grade 3.
IPT:
- ER: Positive (score 8/8).

غرفة رقم (4) – الدور الاول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name	**نجلاء عبدالعظيم محمد محمود**	**Case No.**	**385518**
Sex/Age	**Female 40 Y**	**Patient No.**	**29016**
Registered Date	**19/9/2026 09:15:51 AM**	**Referred By Dr.**	**Out Patient**
Validation Date	**29/9/2026 11:46:23 AM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**07/10/2026 10:35:27 AM**	**Pathology No.**	**2973/26**

- PR: Positive (score 4/8).
- Her2: Positive (score 3+).

- Ki67%: 50%.

***Scoring system: "ER, PR"*
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%
and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
*** Scoring system: "Her2"*
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim, MD.



نجلاء
عبدالحليم محمد محمود
١٩ ش مرزوق ش الترعة البولاقية
الساحل - القاهرة
٢٨٥٠٩٣٠٠١١٢١٠٨
١٩٨٥/٠٩
LI5533139

٠١٠٢٩٤٧٧٠٠٦

٠١٠٥٠٢٧٧٩٠



٢٨٥٠٩٣٠٠١١٢١٠٨ ٢٠٢٥/٠٨
بدون عمل
أنثى مسلمة متزوجة
احمد فاروق محمد سليم
١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٨/٢٣

National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى

رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار :14-9-2026

جهه الاصدار :فرع القاهرة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطيقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) نجلاء عبدالعظيم محمد محمود بطاقة رقم 28509300112108

تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل

وشكرا

تاريخ الطباعه :14-9-2026

الموظف المختص

محمود عبدالله

08986

افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،

مسلسل 2078922

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزراة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى

Non-UHIA Letter
[[DOCTYPE:NON_UHIA_LETTER]]

Naglaa Abd Alazim Mohamed :اسم المريض بالإنجليزية	كود المريض: 99258
2026/09/13 11:31:08 AM :تاريخ التقرير	السن: ٤٠ سنة, ١١ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 40 years old female patient with right breast lump 4 months ago.

Detailed Findings

Right breast:

- Heterogeneously dense (ACR density C).
- The right breast shows locally advanced pathological process inform of middle/posterior 1/3 UOQ and upper central multiple interconnecting ill-defined spiculated dense mass lesions with overlying regional clustered suspicious microcalcifications and thickened skin measuring about 12.5 mm.
- **Ultrasound** revealed locally advanced pathological process inform of three large ill-defined hypoechoic mass lesions seen retroareolar and 9-11 O'clock measuring collectively about 15 x 12.5 cm at its maximum diameters. Associated diffuse echogenic fat lobules with overlying skin thickening.
- Multiple enlarged axillary lymph nodes at level I, II & III with effaced hila, largest one measures about 20 x 12 mm at level I.

Left breast:

- Heterogeneously dense (ACR density C).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated prominent glandular elements of the breast tissue with mottled appearance.
- Well circumscribed hypoechoic mass lesion showing angulated margins seen at 1 O'clock measuring about 15 x8 mm
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Right breast (BIRADS 5): Right locally advanced pathological process with malignant mass lesions with ipsilateral pathological axillary lymph nodes as described. For tru cut biopsy and CESM is recommended.**
- **Left breast (BIRADS 3): Left UOQ probably benign lesion as described likely fibroadenoma.**

Much obliged,
Dr. Rania Mostafa
Dr. Hedaya Nour, MD

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]